جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال محمد عبد السميع ابراهيم
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه ثان **العنوان :** =
رقم البطاقة : 27710091400927 **رقم التليفون :** 01148956813 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 19-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-10-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال محمد عبد السميع ابراهيم
National ID: 27710091400927

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف روسي الترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال محمد عبد السميع ابراهيم

المحافظة : القليوبيه الحي / المدينة : شبرا الخيمه ثان العنوان : =

رقم البطاقة : 27710091400927 رقم التليفون : 01148956813 تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-06-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 09-10-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك المقر بما فيه

الإخصائي الاجتماعي التوقيع:(----------) التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني قسم العلاج : الاورام
حمض الزيلودرونيك (جرعة واحدة) (شامل المتابعه والتحاليل)

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/ احمد نجيب الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

الاسم: د/خالد عبدالعزيز الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

الاسم: د/ محمد الكيلاني الوظيفة: ---------- التوقيع: ----------

جوستاف روسي - مصر

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- ا.د/ ---------- د/ ---------- د/ ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ---------- قسم : ----------

جهة العلاج : ---------- نفقات : ----------

ملاحظات : ----------

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]



DMS

بدل مياه من الريه
مطلوبة



Name: منال محمد عبدالسميع	
MR. : 329	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Anal examination: No visible fissure or piles YET there is a bit stenotic >> for local medictions

12/2025:GEMZAR 800 D1 AND D8 +CARBO AUC 2 D1 AND D8(WT 69 WT 151) C4 D1 : GEM 1360 &CARBO,,,, C4 D8 :GEM &CARBO (PHARMACY) ....HB 7.7 FOR BL TRANSFUSION

clinical pharmacy visit: C4 D8 : GEM 1360 &CARBO,,

PT ON DOUBLET CHEMOTHERAPY GEM CARBO NEW MRI BRAIN REGRESSIVE COURSE NEW CT RD OF PL EFF AND SD OF BREAST LESION NEWLY DEV SCLEROTIC BONY LESION - FOR BONE SCAN + SONOGRAPHY ON RT AXILLA + CONTINUE SAME TTT

A case of breast cancer developed grade 4 hem toxicity. for dose reduction and preferrably changing Gem

for re-attempt of gem carbo at 25% reduction -- PLT spontaneously raised to 138, HB 9.4, tlc 3.7/1.95 for gemzar 600mg/m2, carboplatin auc 1.5 D1 D8 WITH CBC

CBC >> still PLT 67 , hb 7.6 drop after 2 WK s off of CTH >> postpone cycle for new CTS , bone scan then for MDT

still pending new assessment, Hb 12.9 TLC 4.77 ANC 2.65 PLT 90, postpone, give dexa and reassess after Eid

prem mbc to brain pleura and suspected newly developped bone mets and locally recurrent rt breast cancer idc 2 er8/8 pr0/8 her22+ sish not amplified biopsy of rt breast mass 2/2024 .history 2020 prem rt breast cancer ct4b n1 mo er5/8 pr7/8 her2-ve rec nact rt bcs ypt2 ypn1 st zoladex ai till 1/2024 rt operative bed mass and mets to lung st fasoldex ibrance from 3/2024 till 10/2025 brain mets rec wci lung mets and pleural effusion (icu admission and pulmonary embolism st taxol carbopl till 12/2025 dp st gemzar carbopl 3/2026 newly dev osseous lesions pt is deklayed multiple times bec of grade 2 to 3 thrombocytopenia for new cts bs

cts 10/6/2026 moderate left pleural effusion ,multiple bilateral pulmonary nodules largest 9.7mm ,multiple scattered axial and appendicular sclerotic foci . for comp of cts bone scan on 20/6 free pt has grade 3 thrombocytopenia and delayed chemo from 29/4

7/2026 MDT: GEMZAR SINGLE AGENT, OMIT CARBOPLATIN FOR THROMPOCYTOPENIA C2 D1 GEMZAR AFTER LAB

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	الوقت :	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

CT W/ comparison > stationary course for c3d1 gemzar single agent, d8 pharmacy, labs accepted

Pharmacy VIsit BSA: 1.6 FOr C3 D8 Gemzar 1600 Labs 19/8 ... accepted

on exam rt breast skin nodules rt axillary skin nodules for c2 d1 gemzar 1600(2nd cycle after mdt) and liver support alt 61

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 3 / 12 / 2025 G

Name	منال محمد عبد السميع	MRN	2260/2020
		ID	01148956813
Age	48	Phone	01129447585
Menopausal status		Marital status	CVV1..9K..9CY
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	
CO morbidity	DM		

Clinical Data

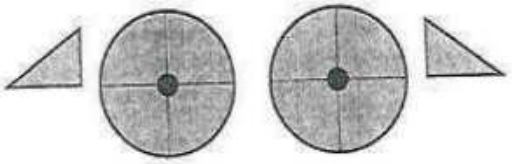
BX:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	0/8	2+ SISH - Ve	

Sonomammography:

Mets Workup:
=) Known case of Rt breast Cancer cT4N1Mx, Received NACT → RT BCS + ALND + PORT - TAM

R L



TNM

PS II → O2 dependant

Recommendations: 2023 → local recurrence + pulmonary Nodules → Femara + Zoladex 1 yr
→ P.D of local breast lesion ! Bx → ER 8/8, PR 0/8, Her-2 2+ Not Amplified → Received Zoladex + Taxotere + Ibrance → (4/2024 → 7/2024
P.D => Brain Mets → Received 4 weeks taxol carbo WEEKLY + WCI then was admitted to ICU with HYPOXIC (Now oxygen dependant)

MDT OUTCOME & PLAN ??? Visceral Crisis pt now O2 dependant. Pt. Urgent doublet chemotherapy. Gemzar, Carboplatin, 800 mg/m² D1+D8 q 21 WEEKLY AUC = 2

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
3/12/2025	3/12/2025				

MDT Form
[[DOCTYPE MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذة / منال محمد عبدالسميع ابراهيم	Request No.	: 13003998
Patient No.	: 27710091400927	Request Date	: 03/02/2024
Path No.	: 457/24	Verification Date	: 14/02/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

CLINICAL DATA
Right CBS with operative bed recurrent malignant looking breast mass.

NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy, collected at 1/2/2024.

GROSS PATHOLOGY
Multiple greyish tissue cores, longest measured 1 cm, totally submited.

HISTOPATHOLOGY
* Histological type: Invasive ductal carcinoma
* Grade (differentiation: nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: No
* Perineural invasion: No
* Angioinvasion: No
* Microcalcifications: No
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Moderate continuous membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Right recurrent breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive ductal carcinoma, Grade II.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 0/8).

Verified by :
walaa ghoniem

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Sonography
[[DOCTYPE SONOGRAPHY]]

Patient Name	:الأستاذه / منال محمد عبدالسميع ابراهيم	Request No.	:13003998
Patient No.	:27710091400927	Request Date	:03/02/2024
Path No.	:457/24	Verification Date	:14/02/2024
Sex	:Female	Financial Category	:اورام دار السلام - فئة الدولة
Age	:46 Y	Department	:Out Patient
Refereing Doc :		Registered by	:Ali mostafa

Pathology Report

- Her2: Equivocal (score 2+) for SISH.
- Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells

Dr.Rana Fathy
Dr.Muhammad Torkey

Verified by :
walaa ghoniem

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE.PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Manal Mohamed Abdel Sameea Ibrahim	Date : 02/11/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2260/2020	Pat. ID: 15559

BREAST HIGH RESOLUTION ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after neoadjuvant chemotherapy of pathologically proved right recurrent breast carcinoma after right CBS ..

Right breast:

- Homogenous fatty background parenchyma.
- Right operative bed infected seroma measuring 19 mm in its max thickness **WITH THICKENED MEDIAL END OF THE SCAR .**
- **THE PREVIOUSLY DESCRIBED MALIGNANT MASS SEEN AT 1 O'CLOCK ,ZONE 3 ,MEASURING (11X 7.5 MM).**
- Normal skin, subcutaneous fat and nipple areola complex.
- **Non specific right axillary LNs.**

Left breast:

- Heterogeneous glandular background parenchyma.
- **No detected suspicious solid or cystic masses.**
- No detected significant left axillary LNs.

Conclusion:

- **Right breast: Stable disease (PR) of the pathologically proved recurrent right malignant mass .... BIRADS 6 category.**
- **Left breast: Normal ... BIRADS 1 category.**

Much Obliged

DR.MONA ZAKY.MD
professor-Breast imaging-Mansoura university

Signature Dr. Mona Zaki
PM 3:53 2025/11/02

Sonography
[[DOCTYPE.SONOGRAPHY]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name: Manal Mohamed Abdel Sameea Ibrahim	Date : 27/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2260/2020	Pat. ID: 15559

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

REVEALED:

Known case of managed right breast cancer, compared to the last CT examination dated 14/04/2025 (hard copy with no DICOM series), the current study revealed:

I- CHEST:

- No significant time interval changes of the previously noted right breast subcutaneous cystic lesion measures about 6.3x4.5 cm with anterior wall calcific focus.
- No significant time interval changes right axillary tail irregular soft tissue density measuring 1.5x1 cm mostly scar tissue.
- Mild progressive course regarding size of bilateral scattered variable sized lung nodules being evident on left side, with the largest is seen at left apical lung lobe measures about 1 cm.
- Newly developed mild to moderate left sided pleural effusion.
- Subcentimeteric mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- The gall bladder is well distended, average wall thickness with no stones.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, aorta and IVC.
    - Newly developed left suprarenal gland (lateral limb) nodule measures about 1.5x1 cm with attenuation value in portal phase about 75 HU.
    - Bulky right sided suprarenal gland.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

CT Scan
[[DOCTYPE.CT_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Patient Name: Manal Mohamed Abdel Sameea Ibrahim	Date : 02/11/2025
Exam : MRI BRAIN	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2260/2020	Pat. ID: 15559

OPEN MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

TECHNIQUE:

Axial T1, T2 and FLAIR WI's
Sagittal T1 WI's
Coronal T2 WIs
Post contrast T1 WIs

FINDINGS:



- Few variable sized lesions are seen at the left cerebral hemisphere as well as a small one in the fontal region, the largest one in the left side measuring about 2.4 x 2 x 1.8 cm in its maximal diameters. They elicit mixed signal in T1 & T2 WIs very faint partial post contrast enhancement. Moderate perifocal edema is seen surrounding the lesions with mild mass effect on the adjacent structures.
- No mid line shift.
- Rather symmetrical appearance of the ventricular system.
- No extra axial areas of fresh blood signal intensities or its degradation products.
- The brain stem and cerebellum is normal.

OPINION:

Findings are suggesting few bilateral cerebral brain metastatic deposits more at the left cerebral hemisphere.

Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR

Sonography
[[DOCTYPE.SONOGRAPHY]]

Name: Mrs/ Manal Mohamed Abd El Samie. **Date;** 28/8/2025.

MULTI-SLICE FDG PET/CT Examination

Clinical history:-

- A 48 years old female, gave history of right breast carcinoma, underwent CBS , received CTH and radiotherapy ended about 5 years ago.

Reason of study:

- PET-CT evaluation.

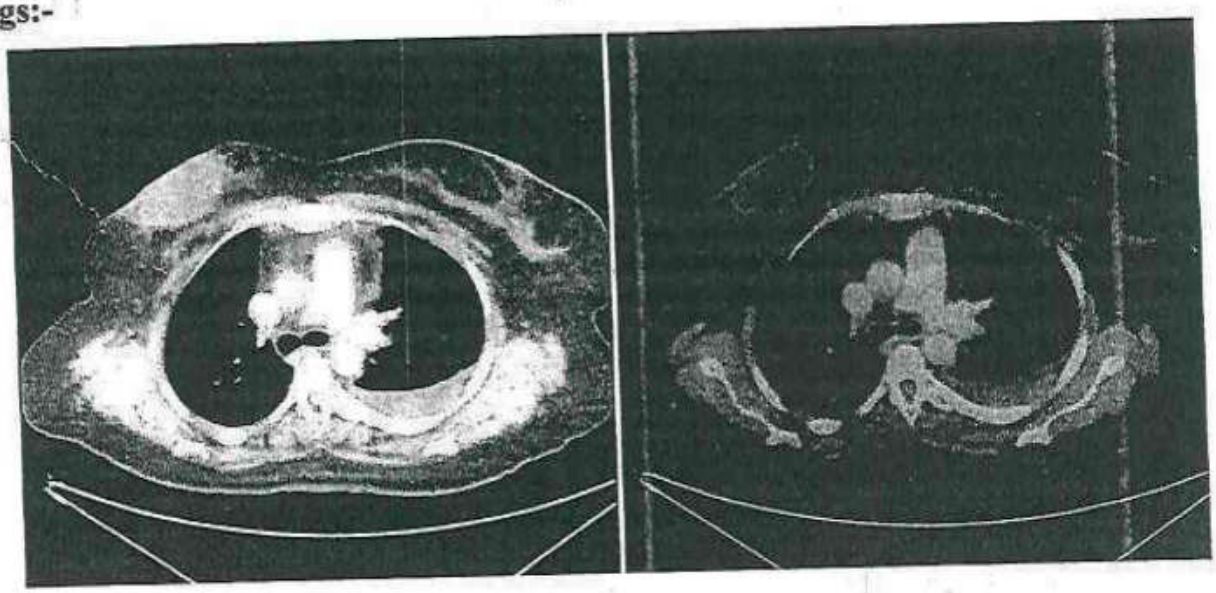
Technique:-

- Approximately one hour after IV administration of around 5 mCi of f-18 FDG. Whole body PET was acquired from the skull level till the mid-thighs. Both arms were placed in extension position above the heads. CT was also done aiming at anatomic localization and attenuation correction and obtaining fusion images. Data was processed and displayed into the usual cuts.

Weight:	78 Kg	Height:	155 Cm
Bl.Gluc.level	124	IV Contrast	Yes

[[DOCTYPE PET_SCAN]]

❖ **Findings:-**



I. **Both breasts /1st site of concern:**

- **Right operative bed showing residual well defined cystic collection (seroma) roughly at UOQ , measuring about 7 x 3.5 cm , of low grade FDG activity , likely post-operative sequel , yet no definite active (FDG avid) soft tissue masses that could account for loco-regional tumoral residual or recurrence.**
- **Associated low active right axillary tail subcutaneous nodule , measuring about 1.4 cm with max SUV~4.1 , ? inflammatory , for clinical correlation .**
- **Normal appearance of the contra lateral left breast with no metabolically active (FDG avid) lesions.**
- **No metabolically active (FDG avid) axillary lymph node.**

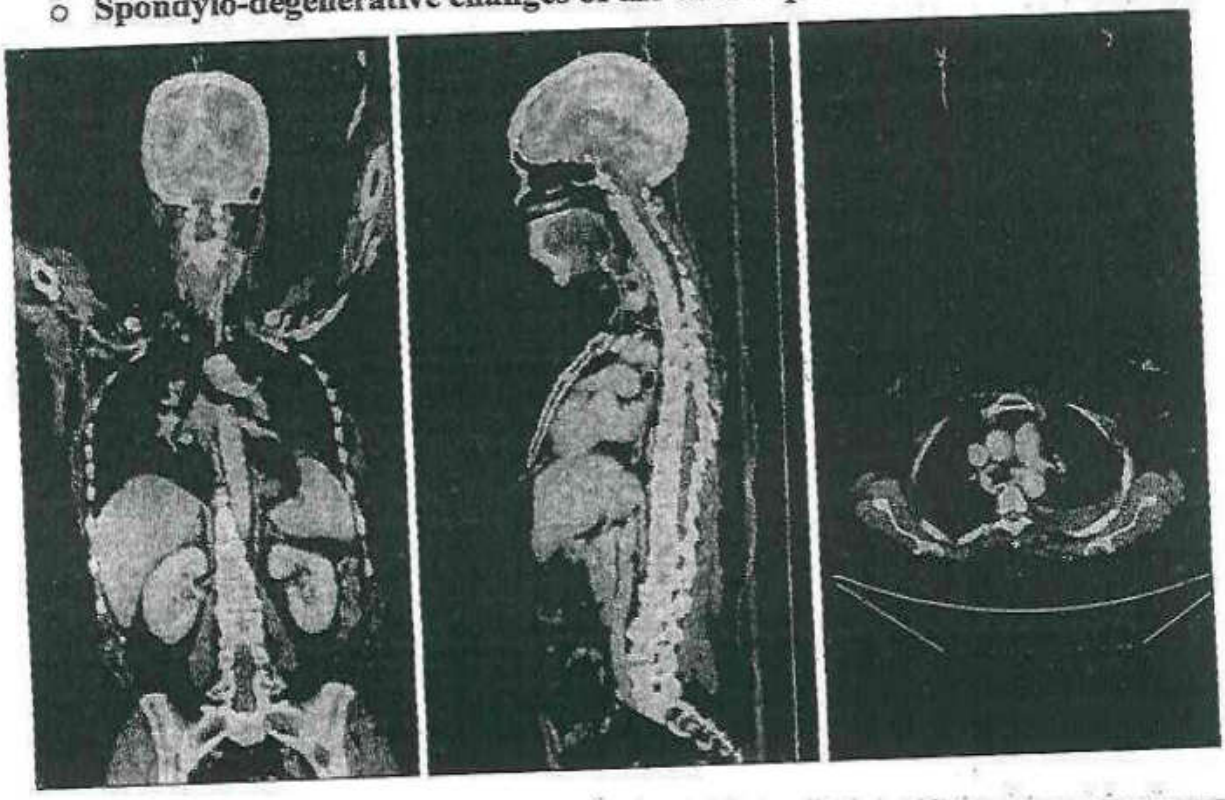
- No metabolically active (FDG avid) right pleural or pericardial effusion.
- Normal appearance of chest wall with no related FDG avid lesions.

V. Abdomen and pelvis:

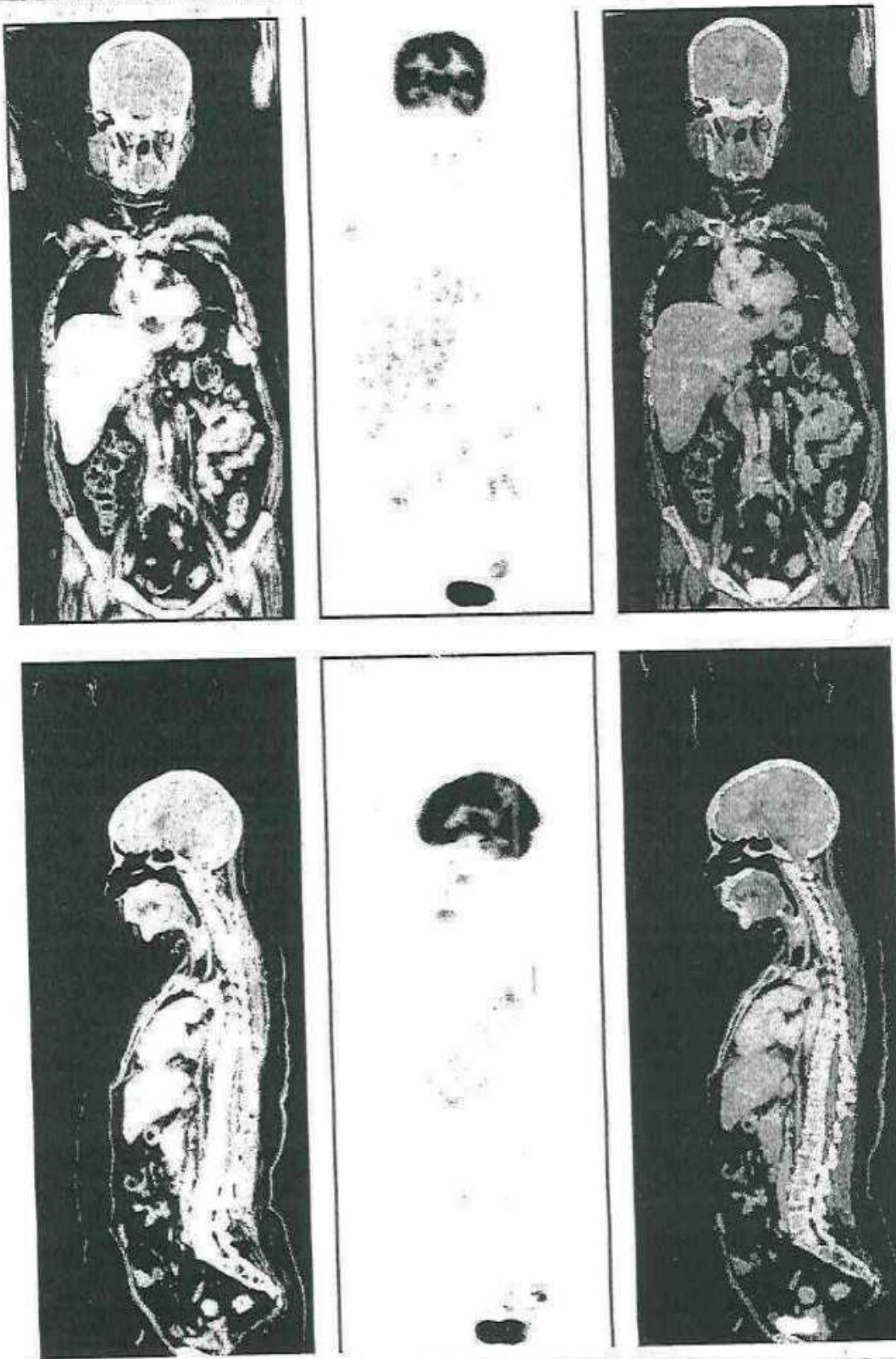
- Mildly enlarged liver showing no metabolically active (FDG avid) focal hepatic lesions.
- Average size spleen showing no metabolically active (FDG avid) focal lesions.
- No metabolically active (FDG avid) abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal tracer concentration and excretion at both kidneys, ureters and urinary bladder.
- Normal appearance of the pancreas, kidneys , right adrenal, aorta and IVC.
- No metabolically active (FDG avid) abdominal ascites.

VI. Scanned axial and Appendicular skeleton:-

- No metabolically active (FDG avid) lytic or sclerotic lesions.
- Spondylo-degenerative changes of the whole spine are noted.



[[DOCTYPE PET_SCAN]]



(+2)24140046 - (+2)24140045 - (+2)0122 8290 029 - (+2)0100 7844 701 - (+2)0155 151 5 732

المستشفى المركزى -شارع عمر ابن الخطاب - ارض الجولف -بجوار سيتى ستارز - مدينة نصر

PET Scan
[[DOCTYPE.PET_SCAN]]